



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

Kognitiv adfærdsterapi med børn

*Af Sonja Breinholst, Bianca Munkebo Christiansen
& Barbara Hoff Esbjørn*

Kognitiv adfærdsterapi med børn



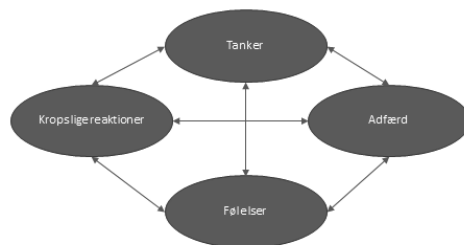
Hvad er kognitiv adfærdsterapi? Og hvor god er denne terapiform til at behandle angst hos børn? Denne artikel besvarer disse spørgsmål ud fra en gennemgang af de virksomme mekanismer, de forskellige formater, samt en gennemgang af effekten af kognitiv adfærdsterapi til børn.

*Af Sonja Breinholst, cand. psych. aut., ph.d., Post Doc.,
Bianca Munkebo Christiansen, cand.psych., videnskabelig assistent,
& Barbara Hoff Esbjørn, professor MSO i klinisk børnepsykologi,
specialist og supervisor i psykoterapi.
Alle ved Center for Angst, Københavns Universitet*

Kognitiv adfærdsterapi

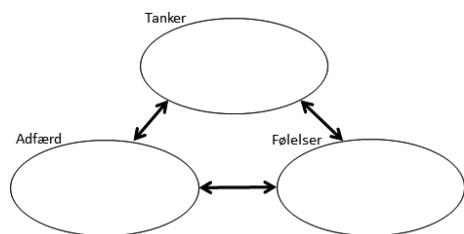
Kognitiv adfærdsterapi, på engelsk kaldet Cognitive Behavioural Therapy (CBT), er udviklet i 1960'erne af den amerikanske psykiater Aaron Beck. Fokus er på menneskets kognitioner, som betyder tanker. Terapien baserer sig på forståelsen af, at tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd hænger sammen i en given specifik situation. I begyndelsen af Aaron Becks arbejde, tog kognitiv adfærdsterapi udgangspunkt i, at det udelukkende var kognitionerne, der påvirkede følelserne og adfærden, og dermed var dem, der via behandling skulle ændres, hvis de var uhensigtsmæssige og ledte til problemer (Beck, Emery & Greenberg, 1985). Denne antagelse er sidenhen blevet ændret, således at man nu forstår sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd som bi-direktionel (Clark & Fairburn, 1997). Det vil sige, at tanker kan på-

virke følelser, kropslige reaktioner og adfærd, men at det lige så vel kan være adfærden, som har en indflydelse på hvilke tanker, følelser og kropslig reaktion, man får. Dette er forsøgt illustreret ved hjælp af den kognitive diamant (se figur 1.), som er grundmodellen indenfor kognitiv adfærdsterapi.



I den ovenstående kognitive diamant sætter man krav til børnene om at kunne skelne mellem kropslige reaktioner og følelser. Ofte vil børnene dog ikke kunne lave sådan en skarp skelnen, men rapporterer typisk disse to som værende det samme. Derfor vil

man typisk i arbejdet med (yngre) børn, gøre det mere simpelt og tage udgangspunkt i og arbejde ud fra den kognitive trekant (se figur 2.). Her gives dermed plads til, at barnet mere spontant kan rapportere f.eks. det at være bange, som værende lig med ondt i maven eller lig med det at have kvalme etc. Det er dog vigtigt, at man, som terapeut, fortsat også får undersøgt hvilke følelser, der er tilstede i en specifik situation, og ikke kun de kropslige reaktioner.



Kognitiv adfærdsterapi retter sig mod identifikation og ændring af de vedligeholdende mekanismer, der fastholder barnet i angsten. Indenfor den kognitive adfærdsterapi forstås angst som et resultat af en fejlfortolkning af en specifik situation. Situationen vurderes som værende truende og farlig, altså helt uden for proportioner med den reelle fare eller risiko (f.eks. *“Hvis jeg laver en fejl i min danskopgave, får jeg aldrig en uddannelse og ender på konstanthjælp”*). Desuden undervurderer barnet sine egne evner og muligheder for at håndtere situationen, hvorfor adfærden bliver at undgå og/eller flygte fra situationen (f.eks. *“Jeg er dum og kan ikke klare danskprøven uden at lave fejl, og derfor bliver jeg hjemme i stedet for at gå i skole den dag vi har*

prøve”). Der arbejdes derfor i terapien med barnets tanker, følelser og adfærd, som de optræder nutidigt i barnets sociale verden (f.eks. i skolen).

Kognitiv adfærdsterapi i praksis – generelle principper

I kognitiv adfærdsterapi lærer barnet at bruge en række specifikke teknikker. Hvilke teknikker der anvendes, i hvilken rækkefølge, og hvor lang tid man bruger på hver, afhænger af barnets problematik og det format, terapien leveres i. Fælles for alle kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb er dog, at de er baseret på et samarbejde mellem barnet og terapeuten. Terapeuten er ekspert på de kognitive teknikker samt patologimodellen, og barnet er ekspert på sine egne tanker, følelser og adfærd. Terapeut og barn arbejder sammen om at udvikle en fælles forståelse af problemet, og i fællesskab opstille hypoteser, der kan testes undervejs i behandlingen. Terapeutens attitude og agenda skal være gennemsigtig for barnet og forældrene, og fremgangen evalueres altid løbende i samspil med barneklienten og familien. Har terapeuten en hypotese, præsenteres og testes denne altid gennemsigtigt for barnet og forældrene (Graham & Reynolds, 2013).

Kognitiv adfærdsterapi indeholder altid en socialisering til metoden, det vil sige en introduktion til, hvordan man forstår tanker, følelser, krop og adfærd, og hvordan man arbejder ud fra sammenhængen mellem dem. Et generelt princip for at hjælpe barnet med at regulere følelser, er at sætte ord på fø-

lelsen. Alene det, at lære barnet at skelne mellem, hvornår der er tale om angst, og hvornår der er tale om andre følelser, herunder vrede, tristhed, ked-somhed m.v., kan hjælpe barnet med at få lidt bedre kontrol over følelserne.

En socialisering til den kognitive trekant giver barnet og familien en ramme til at forstå deres problemstilling, samt et fælles sprog og udgangspunkt sammen med terapeuten til at arbejde med problemet. Den kognitive trekant fungerer som en caseformulering eller problemformulering, det vil sige som en forståelse af barnets problematik skræddersyet ud fra det enkelte barns og familiens egne eksempler på problemforståelsen. Dette kræver en grundig udredning af barnets symptomer samt de vedligeholdende, udløsende og disponerende faktorer (Dummett, 2013). En caseformulering er grundlaget for behandlingens fokus, en form for arbejdsplan med hypoteser som løbende gennem terapien bliver revideret og ændret. Terapeuten og barnet bruger derfor caseformuleringen undervejs i behandlingsforløbet som et pejlemærke i forhold til om tankerne og adfærden har ændret sig, og om angsten dermed er blevet reduceret. Man kan således bruge den kognitive trekant til at identificere og vurdere tanker, følelser, adfærd og kropslige symptomer i en specifik situation, men ligeledes til at tage udgangspunkt i, hvordan barnet selv, forældrene eller terapeuten ønsker, at barnet skal reagere og tænke i situationen fremadrettet, samt til at tjekke op på frem- eller tilbagegang fra session til session. Caseformuleringen kan dermed indled-

ningsvist i behandlingen også give anledning til at psykoeducere generelt om angsten, hvor de mekanismer som anses for at vedligeholde angsten konkretiseres (Drinkwater, 2005).

For at opnå et succesfuldt behandlingsforløb, er det vigtigt at opstille målsætninger for behandlingen, således at både barn, forældrene og terapeuten ved, hvad der skal arbejdes med og henimod. Det er vigtigt, at målsætningerne er specifikke, konkrete og målbare, sådan at det hele tiden løbende er muligt at vurdere, hvorvidt behandlingen har den ønskede effekt. Børn kan have svært ved at finde ud af, præcis hvad de ønsker at få ud af behandlingen, og kan derfor have brug for hjælp til at finde ud af, hvilke mål for behandlingen, der bør være. Dette skyldes til dels, at de måske ikke kan huske tilbage til, at de ikke havde angst, og dermed ikke kan forestille sig, hvordan det vil være at leve et liv uden angst. Endvidere er barnet oftest ikke selv initiativtager til at gå i behandling, og ser egentligt ikke, at det har et problem. Derfor kan der være forskel på barnets og forældrenes mål for terapien. Som udgangspunkt tages der afsæt i barnets ønsker, idet det styrker motivationen og arbejdslysten hos barnet. Har forældrene dog nogle klare ønsker for, hvad de ønsker ændret, for at få familien og hverdagen til at fungere igen (f.eks. at barnet skal kunne være i skolen alene uden mor og far, sådan at forældrene kan opretholde et arbejde), så sætter man dette på som mål. Det vil dog her være særligt vigtigt at psykoeducere barnet om forskellen på bør-

ne- og voksenansvar, at det er forældrene, der som de voksne i familien, i sidste ende bestemmer. Som oftest vil man have fokus på at arbejde med et mål af gangen i behandlingen, og her vil det være motiverende for barnet at begynde med et mål, det selv har valgt.

Det, der adskiller et kognitivt adfærds-terapeutisk børneforløb fra et voksent er, at barnet som nævnt ovenfor, ofte ikke selv har bedt om hjælp. I nogle tilfælde oplever barnet ikke engang, at det har et problem, der skal tages hånd om (det er f.eks. ikke et problem for barnet at mor eller far skal køre det i skole hver dag, fordi barnet er bange for at tage bussen alene. Det er udelukkende et problem for forældrene, der hver dag kommer for sent på arbejde). I andre tilfælde kan barnet godt se, at det hæmmes af sin angst (f.eks. hvis barnet sover i mors og fars seng, og det derfor aldrig har nogen venner med hjemme og sove, fordi det synes det er pinligt, hvis vennerne opdager, at han/hun stadig sover med sine forældre). Derfor arbejder man i kognitiv adfærdsterapi med positiv forstærkning i form af ros og belønning, ud fra en social indlæringssteoretisk forståelse af, at det vil gøre barnet mere motiveret samt få det til at gøre mere af den ønskede adfærd. Belønning består af mange ting. Ros og opmuntring er begge vigtige motiverende elementer, men man kan også belønne direkte med f. eks. små slikposer, alene tid med mor eller far, eller et lille stykke legetøj. Videre kan belønningerne systematiseres ved at indføre et belønningsskema eller stjerneschema, hvor barnet kan optjene

point eller stjerner, når barnet har udvist modig adfærd. Barnet tjener på den måde op til en større belønning (f.eks. et computerspil, stor pakke Lego mv.). Forældre til børn i kognitiv adfærdsterapi instrueres i, hvordan de på bedste vis roser og belønner et barn, således dets interesse og motivation vækkes. Belønningssystemerne er ofte noget, som barnet og forældrene administrerer i forhold til hjemmeopgaver mellem sessioner, men barnet kan ligeledes belønnes i terapien af terapeuten. Når behandlingseffekten efter et par uger tiltager, vil dét, at have lært at kontrollere angsten og kunne gøre noget af det, der tidligere var svært (f.eks. have venner sovende), oftest være den stærkeste motivation og drivkraft, hvorfor belønninger og et fast belønningssystem fases ud, i takt med at barnet klarer mere og mere selv.

Kognitiv adfærdsterapi er en aktiv terapiform, hvor terapeuten og barnet arbejder med de beskrevne redskaber i hver session. For at få en god effekt af behandlingen er det ligeledes en forudsætning og et krav, at barnet laver hjemmeopgaver dagligt mellem sessionerne. Hjemmeopgaverne tager som oftest afsæt i dagens session, og aftales på forhånd med barnet. I nogle tilfælde bliver det nødvendigt at involvere forældrene heri, idet de skal hjælpe barnet (f.eks. hvis barnet skal øve sig på et trin i forhold til det overordnede mål at sove alene på eget værelse. Her er det måske nødvendigt, at forældrene et stykke tid rykker ud af barnets værelse og sidder udenfor på gangen indtil barnet falder i søvn).

Er kognitiv adfærdsterapi egnet til børn?

Eftersom at kognitiv adfærdsterapi med børn tager afsæt i modeller fra voksne, er der til tider blevet sat spørgsmålstegn ved, om børn har udviklet de særlige kognitive kompetencer, der kræves for et vellykket kognitivt adfærdsterapeutisk forløb. Forskning på området viser, at børn omkring skolealderen (5-7 år) mestrer de færdigheder, dette kræver, nemlig at forstå, at tanker kan undersøges og evalueres, og at mentale tilstande er styrende for ens og andres adfærd og kan kontrolleres (Bolton, 2005). Som med al anden behandling af børn, er det ligeledes indenfor kognitiv adfærdsterapi vigtigt at tilpasse behandlingen til barnets problemstilling, alder samt kognitive færdigheder. I kognitiv adfærdsterapi gælder det som udgangspunkt, at jo yngre barnet er, eller jo dårligere sproglige og/eller kognitive færdigheder det har, desto mere vil man arbejde med og have fokus på adfærdsændringer (Stallard, 2007). Man kan derfor indenfor kognitiv adfærdsterapi (KAT) lave mere eller mindre KaT (stort K=kognitivt arbejde) eller kAT (stort A= adfærdsarbejde), eller veksle mellem disse to former.

Med den ovenstående generelle introduktion til hvordan der arbejdes i kognitiv adfærdsterapi, vil vi nedenfor beskrive de mest anvendte og virksomme mekanismer og teknikker indenfor kognitiv adfærdsterapi. Der kan læses mere konkret og i dybden omkring disse i Stallards bog *Vejledning til gode tanker, gode følelser* (Stallard, 2007)

samt i bogen *Angst hos børn* (Leth & Esbjørn, 2012). Ofte vil kognitiv adfærdsterapi foruden disse teknikker yderligere gøre brug af afledning, vejrtækningsteknikker, opmærksomhedstræning (Friedberg & McClure, 2002; Graham & Reynolds, 2013). Disse redskaber bruges primært til at reducere barnets angst tilstrækkeligt til, at barnet kan arbejde bevidst med de tanker (omstrukturering) eller den adfærd (eksponering), der udløser eller vedligeholder angsten.

1. Kognitiv omstrukturering

En af de grundlæggende teknikker indenfor kognitiv adfærdsterapi er udfordring og omstrukturering af uhensigtsmæssige tanker. Idet kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i, at oplevelsen af angst er koblet til uhensigtsmæssige tanker og tankeprocesser, er første skridt en identifikation af disse negative tanker og processer. Dernæst følger en undersøgelse og udfordring af disse for at få en mere realistisk forståelse af dem. Når barnet har fået et mere realistisk perspektiv på sine negative tanker, antages dette at mindske og i sidste ende helt afhjælpe angsten. Ved kognitiv omstrukturering tages der afsæt i en helt specifik situation, som har ført til følelser af angst, nervøsitet eller bekymring. Trinnene i kognitiv omstrukturering er som følger:

- 1) Det undersøges, hvilke negative automatiske tanker/forestillinger/billeder, der gik gennem hovedet på barnet i den pågældende situation. Jo mere specifik situationen beskrives, jo nemmere vil det være at fremkalde erindringer om tankerne. Til de helt små

børn kan man bruge billedmateriale med tankebobler, hvor man kan spørge: "Hvad tror du, drengen/pigen på billedet tænker?". Eksempler på negative automatiske tanker, som angste børn kan have, er: "*Jeg kan ikke klare det*", "*De vil grine af mig*", "*Der sker noget forfærdeligt med mine forældre og jeg bliver alene tilbage*". 2) Når tankerne er identificeret, vurderes, hvor meget barnet tror på den negative automatiske tanke. Inden for kognitiv adfærdsterapi bruger man en skala fra 0-10 til de fleste typer vurderinger. 3) Derefter hjælper terapeuten barnet med at udfordre og omstrukturere de negative uhensigtsmæssige tanker til mere realistiske tanker. Dette gøres ved at finde beviser *for* og *imod*, at den uhensigtsmæssige tanke skulle være rigtig. 4) På baggrund af denne undersøgelse, findes en mere realistisk tanke. 5) Ved det sidste trin i kognitiv omstrukturering måler man, hvor meget barnet tror på den nye realistiske tanke. Formålet er at finde frem til en mere realistisk tanke, som barnet kan tro på, og som ikke vækker samme niveau af angst. Såfremt barnet ikke tror på den nye realistiske tanke, vil det være nødvendigt at vende tilbage til bevisførelsen og tjekke, om der er nogle beviser, som der er blevet undladt *for/imod*.

Når man arbejder med børn tilpasser man selvfølgelig sproget til barnets alderstrin. Derfor kaldes kognitiv omstrukturering ofte for "detektivtænkning" eller lignende. Man kan endvidere kalde de negative uhensigtsmæssige tanker for "drilletanker" og den nye mere realistiske tanke for "hjælpetanken".

2. Eksponering

En anden virkende mekanisme i kognitiv adfærdsterapi er gradvis eksponering. Få børn – og voksne – oplever, at angst går væk, blot ved at tale om drilletanker og identificeret hjælpetanker på baggrund af kognitiv omstrukturering. Dét, at øve sig i at være i situationer, der udløser angst, og erfare, at det ikke er så slemt, som man troede, og at man kan håndtere det, er faktisk dén teknik, der inden for forskningen, opnår størst effekt i forhold til behandling af angst hos børn (Chorpita et al. 2002; Kendall et al., 2005). Gradvis eksponering handler om, at barnet langsomt arbejder sig hen mod at kunne klare at være i angstprovokerende situationer. Den gradvise eksponering opbygges af en række delopgaver, som fører frem mod barnets overordnede mål. Det kan for eksempel være, at barnet ønsker at kunne sove ude hos en ven. Man laver her en liste over de ting, barnet skal kunne inden for overhovedet at kunne sove ude. Det kan eksempelvis være at kunne falde i søvn selv, at kunne klare sig selv, hvis det vågner om natten, og at kunne sove i mørke, etc. Nogle børn vil være bange for flere af disse ting, andre kun for nogle og andre igen er blot bange for elementer af oplevelsen. Sammen med barnet finder man ud af, hvad det er, barnet er bange for, og hvad der er lettest, mellemsvært og svært. Når man arbejder med børn, vil man ofte illustrere det ved at lave trapper eller trappestiger, som det gradvist skal klatre op af (Stallard, 2006). Barnet begynder med det letteste trin og kravler op ad stigen til det sværeste trin.

Under en eksponering vil terapeuten hele tiden måle graden af angst fra 0-10 sammen med barnet, for på den måde at påpege og tydeliggøre overfor barnet, at angsten falder ved tilvæning til den angstprovokerende situation.

FORMAT

Kognitiv adfærdsterapi kan være enten manualbaseret eller caseformuleringsbaseret. Den manualbaserede tager som navnet indikerer udgangspunkt i behandlingsmanualer for en given lidelse. Her er hver enkel session, dens indhold samt hjemmearbejde bestemt på forhånd, hvilket gør det svært at tilpasse terapien til det enkelte barn og dets familie. Det stiller derfor ekstremt store krav til udredningen og diagnosticeringen af barnet og dets familie, da man ikke undervejs kan justere/ændre/tilpasse behandlingen. Den mest kendte og udbredte manual er Cool Kids, som er en manualbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk gruppebehandling af angst hos børn (Rapee et al., 2006).

Caseformuleringsbaseret eller problemformuleringsbaseret behandling tager udgangspunkt i den problemforståelse, som terapeut og barn (i samarbejde med forældre) har lavet sammen i starten af forløbet, og som gennem hele behandlingen vurderes og revideres. Det er en individualiseret tilgang, der tilpasser behandlingen til det enkelte barn. Behandlingen er derfor, modsat den manualbaserede, ikke på forhånd fastlagt; sessionerne, deres indhold og format samt hjemmearbejdet styres af og justeres i forhold til den underliggende problemforståelse,

nemlig caseformuleringen. Både progression og opståede problemer i behandlingsforløb anvendes som information til at opdatere den kognitive forståelse. Caseformuleringsbaseret kognitiv adfærdsterapi er ofte anvendt i hverdagens klinikker, selvom manualen Cool Kids, også i de seneste år er blevet yderst populær og udbredt både i kommuner og blandt privatpraktiserende.

Kognitiv adfærdsterapi kan, underordnet om det er manualbaseret eller caseformuleringsbaseret, udbydes individuelt eller i grupper. Begge behandlingsformer har ugentlige sessioner, hvor de individuelle typisk varer 45 minutter, og gruppesessionerne 1,5-2 timer afhængig af antal deltagere. Ofte består grupperne af 6-8 børn og to terapeuter. En fordel ved gruppeforløb er, at barnet har bedre mulighed for at lære af og finde inspiration i de andre børns måde at arbejde på, samt opdagelse, at der er andre med samme problemer som én selv. Dermed normaliseres angsten. En ulempe er, at tiden skal fordeles mellem mange børn, ofte med forskellige problematikker. Underordnet format vil et typisk kognitivt adfærdsterapeutisk forløb strække sig over 3-4 måneder med en ugentlig samtale, når der er tale om moderat til svær angst. Hvis der er flere komorbide (angst)lidelser af svær grad, kan behandlingen strække sig over længere tid afhængig af problemstilling og sværhedsgrad.

Når man behandler børn, er der yderligere mulighed for at have forældre med i terapien uanset om behandlingen er individuel eller gruppebaseret. Forældre kan involveres på forske-

lig vis. De kan være co-terapeuter, co-klienter eller forældreterapeuter. I førstnævnte er der typisk tale om almindelig barneterapi, hvor barnet modtager behandlingen, og forældrene de sidste 5-10 minutter af sessionen får et kort resume over, hvad der er blevet arbejdet med i sessionen, samt hvad hjemmeopgaven til næste gang er. I de tilfælde forældrene deltager som co-klienter, er behandlingsforløbet delt op således, at børnene modtager halvdelen af sessionerne (ca. 6-7 stykker), og forældrene de resterende (ca. 6-7 stykker). I forældrebehandlingen arbejdes der med forældrenes uhensigtsmæssige tanker og adfærd, som kan være vedligeholdende for barnets angst. I de tilfælde forældrene er terapeuter, formidles behandlingen til forældrene, som dernæst skal gå hjem og udføre den med barnet/den unge. Dette bruges primært til de helt unge børn (Cartwright-Hatton, 2010), eller som ressourcebesparende behandling (se artikel om Hjælp til Selvhjælp i nærværende særnummer).

Effekten af kognitiv adfærdsterapi til børn med angst

Begrebet evidensbaseret praksis er udviklet af lægevidenskaben, og omhandler hvordan undersøgelse, forebyggelse og behandling af en given lidelse skal baseres på forskningsresultater. I takt med indførelsen af nye undersøgelses- og behandlingsformer samt en øget efterspørgsel efter disse, er man blevet opmærksom på, at psykologer ligeledes skal forholde sig til deres praksis og til, om denne er evidensbaseret (Hougaard, 2007). Når man arbejder evidensbaseret, bør man forholde sig til

følgende: 1) den viden, der kommer fra den bedst tilgængelige forskning, 2) sin egen kliniske kompetence og erfaring, og 3) hvad der karakteriserer det enkelte barn og dets familie (Hougaard, 2007). Når man inddrager viden fra forskning i sine kliniske beslutninger, er viden om den overordnede effekt af den behandling, som man overvejer at anvende, særdeles vigtig. I forhold til effekten af behandling til angst børn, er kognitiv adfærdsterapi den mest udbredte og bedst validerede behandling til børn og unge med angst (Sundhedsstyrelsen, 2015). På nuværende tidspunkt er der ikke forskningsmæssigt belæg for at andre former for behandling, herunder familierapier eller psykodynamiske terapier er lige så effektive til at behandle klinisk patologisk angst som de kognitive terapier.

Der er lavet adskillige randomiserede kontrollerede forsøg samt metaanalyser, hvor man har samlet data fra en stor mængde undersøgelser af kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angst hos børn. En sådan metaanalyse rapporterer, at ca. 60% af børnene er fri for al angst efter endt behandling (James et al. 2013; James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Den positive effekt af behandlingen ses uanset format. Det vil sige, at kognitiv adfærdsterapi er lige effektivt, uanset om det bliver givet individuelt eller i grupper, om behandlingen tilpasses barnets problem i et caseformuleringsbaseret tilbud, eller om der gives et manualbaseret tilbud. Dog viser forskningen, at effekten af kognitiv adfærdsterapi er væsentligt bedre, når behandlingen udføres ved

universitetsklinikker end i hverdagens praksis. Dette kan forklares ved, at disse terapeuter som oftest er uddannede og certificerede i kognitiv adfærdsterapi samt modtager mere kvalificeret og specialiseret supervision (Ishikawa et al., 2007). Dette er generelt vigtige faktorer, når man ønsker at opnå samme høje effekt i hverdagens praksis som i studier af kognitiv adfærdsterapi. Arbejder man manualbaseret, er det desuden vigtigt at huske, at effekten kræver, at man følger manualen fra gang til gang (Rapee, 2006).

Så kognitiv adfærdsterapi virker – og hvad så?

Fra forskningen ved vi, at kognitiv adfærdsterapi virker; lidt over halvdelen af børnene bliver fri for alle deres angstlidelser. Men hvad med resten af børnene? Gennem årene har forskere forsøgt at øge effekten af behandlingen. Et element, der har haft særlig stor bevågenhed, er om inddragelse af forældre i behandlingen kan øge effekten, fordi forældrene har mulighed for at støtte barnet mellem sessionerne og efter behandlingens afslutning. Der er fortsat ingen tydelige svar på det spørgsmål (Breinholst et al., 2012). En af årsagerne til det manglende fund af en øget behandlingseffekt ved inddragelse af forældre kan være, at man ofte ikke har arbejdet med de faktorer, man ved, fastholder angsten i familien. En metaanalyse på området har dog vist, at behandling, der aktivt overdrager kontrol til forældre, så *forældrene* lærer at træne modig adfærd og eksponering med deres barn, er signifikant mere effektiv efter et år end behandling uden dette fokus (Ma-

nassis et al., 2014). Et studie af danske familier har også fundet, at der ikke var nogen forskel på behandlingseffekt umiddelbart lige efter og 6 måneder efter endt behandling hos angst børn, der havde haft større eller mindre grad af forældreinddragelse i deres behandling. Interessant nok, fandt man, at efter 3 år, var flere af børnene, hvor forældrene havde været aktivt inddraget i behandlingen, fortsat fri af angst ved 6 måneders og 3 års opfølgningen sammenlignet med gruppen af børn, der ikke havde haft samme grad af forældreinvolvering i behandlingen (Walczak et al., 2017).

Konklusion

Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte evidensbaserede praksis til behandling af klinisk angst hos børn. Terapien baserer sig på empirisk forskning og fokuserer på at ændre problemerne ved at afhjælpe uhensigtsmæssige tanker og adfærd. Kognitiv adfærdsterapi er baseret på forståelsen af, at angst udvikles og vedligeholdes af uhensigtsmæssige forvrængede tanker om overdreven fare, og uhensigtsmæssige adfærdsstrategier så som undgåelse. Kognitiv adfærdsterapi er problemfokuseret og handlingsorienteret, hvilket betyder at den bruges til at behandle specifikke psykiske lidelser. Terapeutens rolle er, at hjælpe barnet og familien med at opstille mål for behandlingen og identificere uhensigtsmæssige kognitive og adfærdsmæssige strategier hos barnet, samt hjælpe barnet til at gøre brug af mere hensigtsmæssige strategier, for på den måde at reducere angsten.

Referencer

- Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive approach. *Basic, New York*.
- Bolton, D. (2005). Cognitive behaviour therapy for children and adolescents: some theoretical and developmental issues. In, Graham (ed.), *Cognitive behaviour therapy for children and families*, (chapter 2, pp.9-24, 2.ed.) London: Cambridge University press..
- Breinholst, S., Esbjørn, B. H., Reinholdt-Dunne, M. L., & Stallard, P. (2012). CBT for the treatment of child anxiety disorders: A review of why parental involvement has not enhanced outcomes. *Journal of Anxiety Disorders*, 26(3), 416-424.
- Cartwright-Hatton, S. (2010). *From timid to tiger: A treatment manual for parenting the anxious child*. John Wiley & Sons.
- Chorpita, B. F., Yim, L. M., Donkervoet, J. C., Arensdorf, A., Amundsen, M. J., McGee, C., ... & Morelli, P. (2002). Toward Large Scale Implementation of Empirically Supported Treatments for Children: A Review and Observations by the Hawaii Empirical Basis to Services Task Force. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 9(2), 165-190.
- Clark, D. M. E., & Fairburn, C. G. (1997). *Science and practice of cognitive behaviour therapy*. Oxford University Press.
- Drinkwater, J. (2005). Cognitive case formulation. *Cognitive behaviour therapy for children and families*, 2, 84-99.
- Dummet, N. (2013). Formulation: a systemic approach in cognitive behaviour therapy. *Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families*, 69.
- Friedberg, R. D., & McClure, J. M. (2002). Clinical practice of cognitive behavioral therapy with children and adolescents: The nuts and bolts.
- Graham, P., & Reynolds, S. (Eds.). (2013). *Cognitive behaviour therapy for children and families*. Cambridge University Press.
- Hougaard, E. (2007). Evidens: Noget for psykologer. *Psykolog Nyt*, 20, 14-21. In-Albon, T. & Schneider, S. (2007). Psychotherapy of childhood anxiety disorder: A meta-analysis. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 76, 12-24.
- Ischikawa, S., Okajima, I., Matsuoka, H. & Sakano, Y. (2007): Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorders in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Child and Adolescent Mental Health*, 12, pp. 164-172.
- James, A. C., James, G., Cowdrey, F. A., Soler, A., & Choke, A. (2015). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. *the cochrane library*.
- James, A. C., James, G., Cowdrey, F. A., Soler, A., & Choke, A. (2013). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*, 6.
- Kendall, P. C., Robin, J. A., Hedtke, K. A., Suveg, C., Flannery-Schroeder, E., & Gosch, E. (2005). Considering CBT with anxious youth? Think exposures. *Cognitive and Behavioral Practice*, 12(1), 136-148.
- Leth, I. & Esbjørn, B. H. (Eds.). (2012). *Angst hos børn. Kognitiv terapi i teori og praksis*. Dansk Psykologisk Forlag.
- Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., Zhao, X. Y., Mendlowitz, S., Duda, S., ... & Bodden, D. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: A preliminary meta-analysis.
- Rapee, R. M., Lyneham, H. J., Schniering, C. A., Wuthrich, V., Abbott, M. A., Hudson, J. L., & Wignall, A. (2006). *Cool Kids: Child & Adolescent Anxiety Program*. Centre for Emotional Health.
- Stallard, P. (2006). *Gode tanker-gode følelser: kognitiv adfærdsterapi med børn og unge*. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
- Stallard, P. (2007). *Vejledning til Gode tanker-gode følelser: kognitiv adfærdsterapi med børn og unge*. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
- Sundhedsstyrelsen (8. september 2015): <http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#>
- Walczak, M., Esbjørn, B. H., Breinholst, S., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2017). Parental involvement in cognitive behavior therapy for children with anxiety disorders: 3-year follow-up. *Child Psychiatry & Human Development*, 48(3), 444-454.